การประชุมแลกเปลี่ยน

การศึกษาสถานการณ์การจัดบริการดูแลระยะยาวในชุมชนของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน

ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, อ.นพ.ณัฐวุฒิ เอี่ยงธนรัตน์, อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย, อ.นพ.ปวินท์ ศรีวิเชียร, นพ.พีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์*, พิวัฒน์ ศุภวิทยา, ปุญญพัฒน์ พันนาค
คณะผู้วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: peerasit.sit@mahidol.ac.th





หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

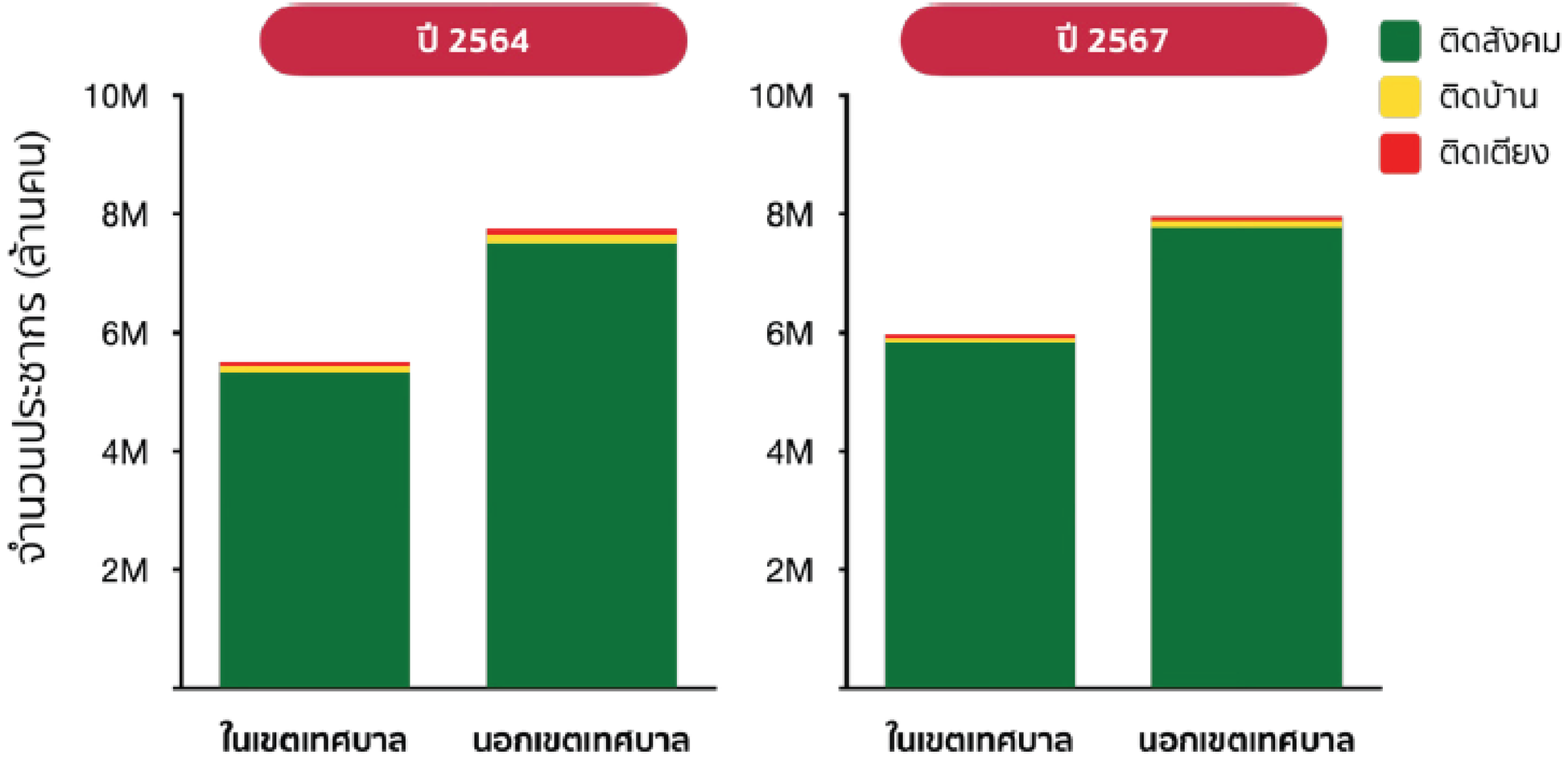




การวิเคราะห์ฐานข้อมูล
การสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย

ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ



ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ลักษณะของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

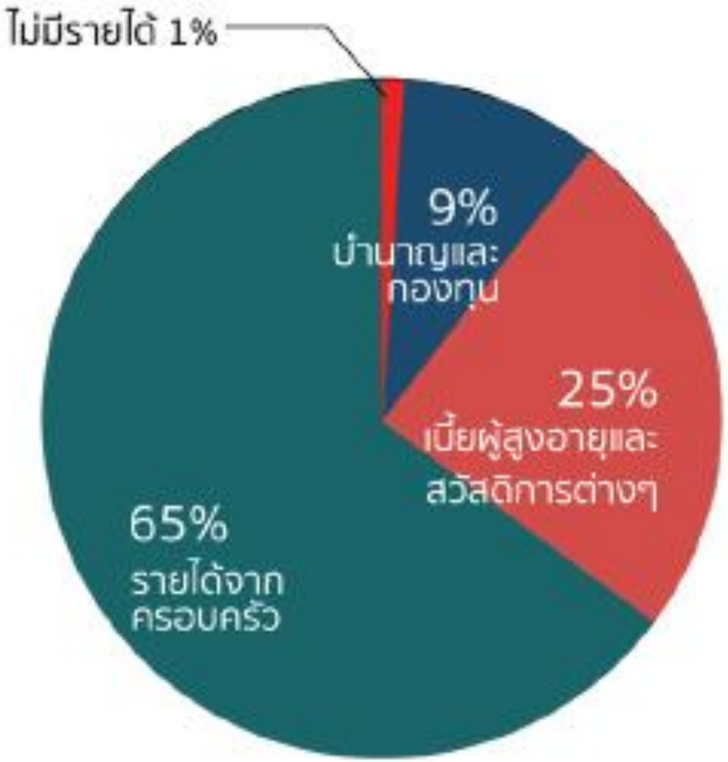
ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 149,958	นอกเขตเทศบาล n = 188,091
เพศ		
ชาย	43,505 (29.01%)	67,731 (36.01%)
หญิง	106,453 (70.99%)	120,360 (63.99%)
อายุ	68 (63–74)	68 (64–75)
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	129,596 (86.42%)	178,566 (94.94%)
มัธยมศึกษา	11,864 (7.91%)	6,408 (3.41%)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	8,497 (5.67%)	3,117 (1.66%)
คำนวณจากค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่าง		

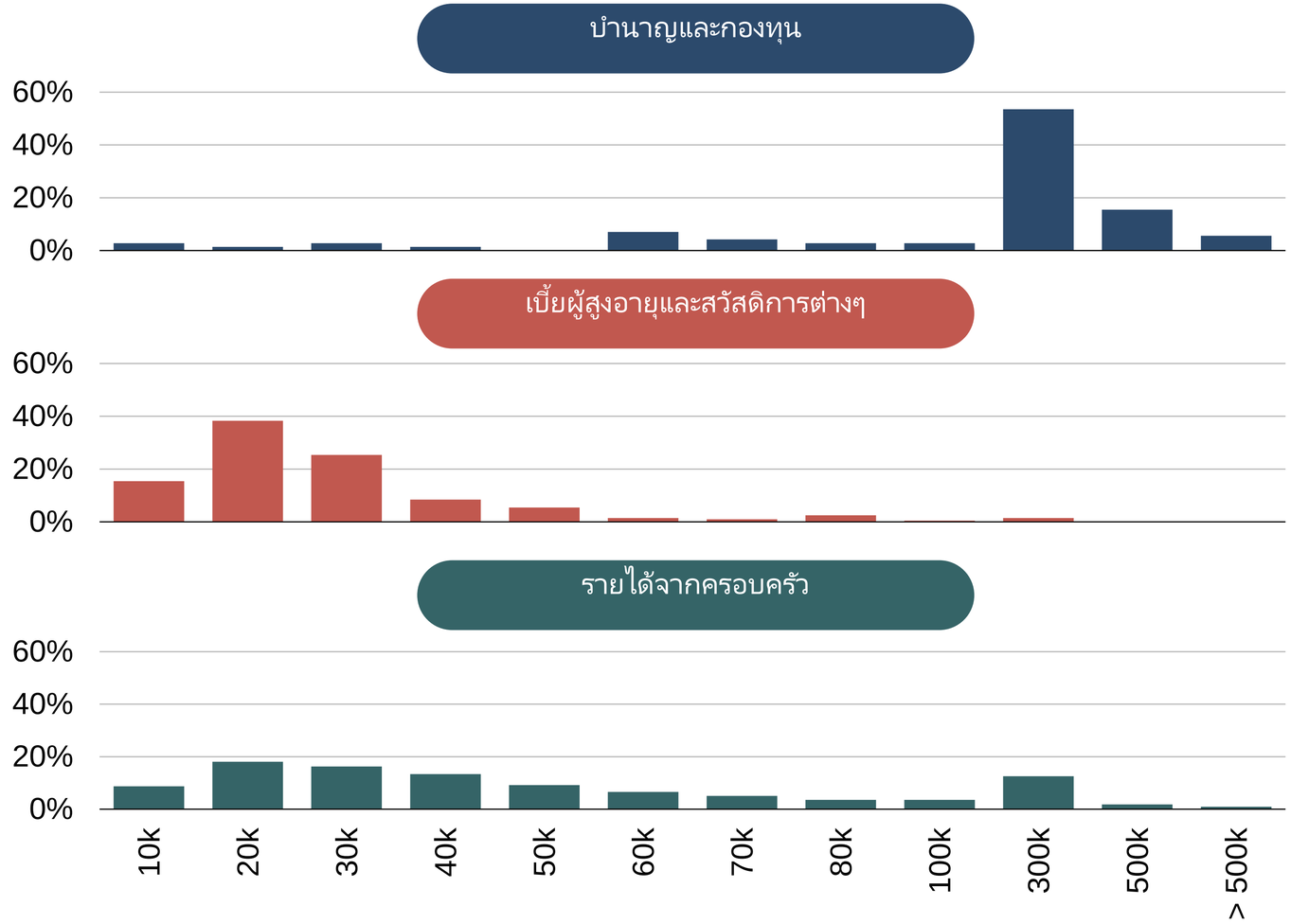
ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ในเขตเทศบาล

รายได้หลักของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง



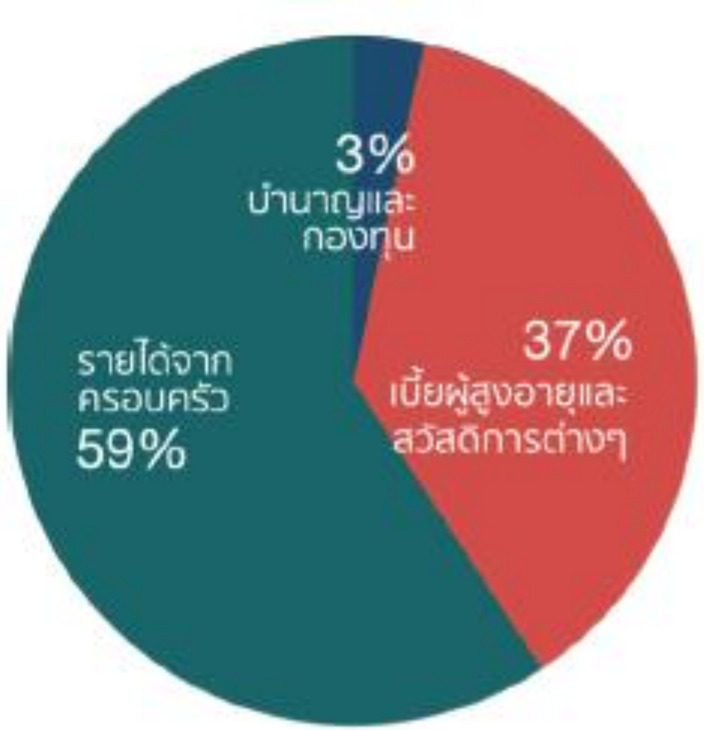


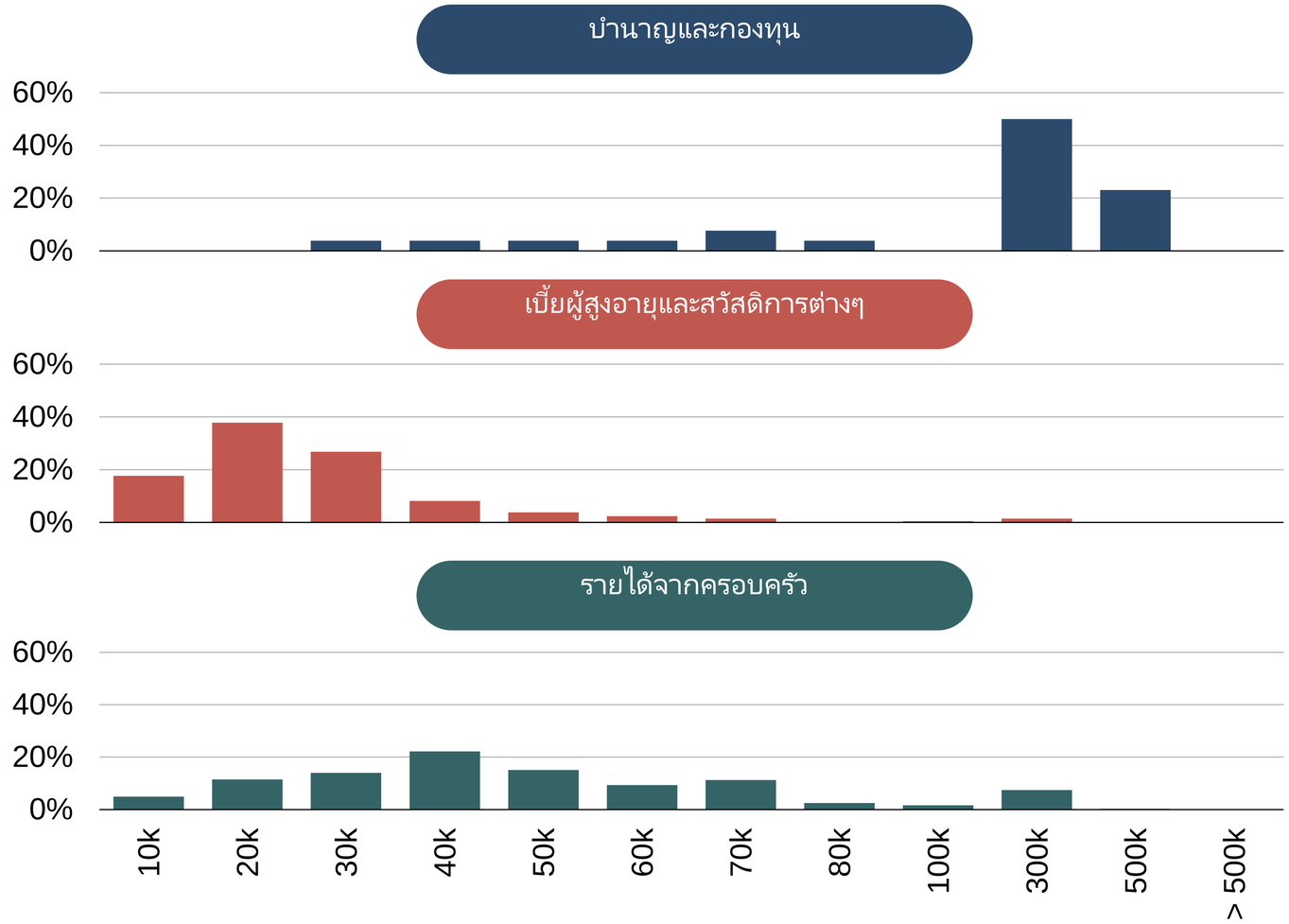
ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นอกเขตเทศบาล

รายได้หลักของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง





ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ลักษณะของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

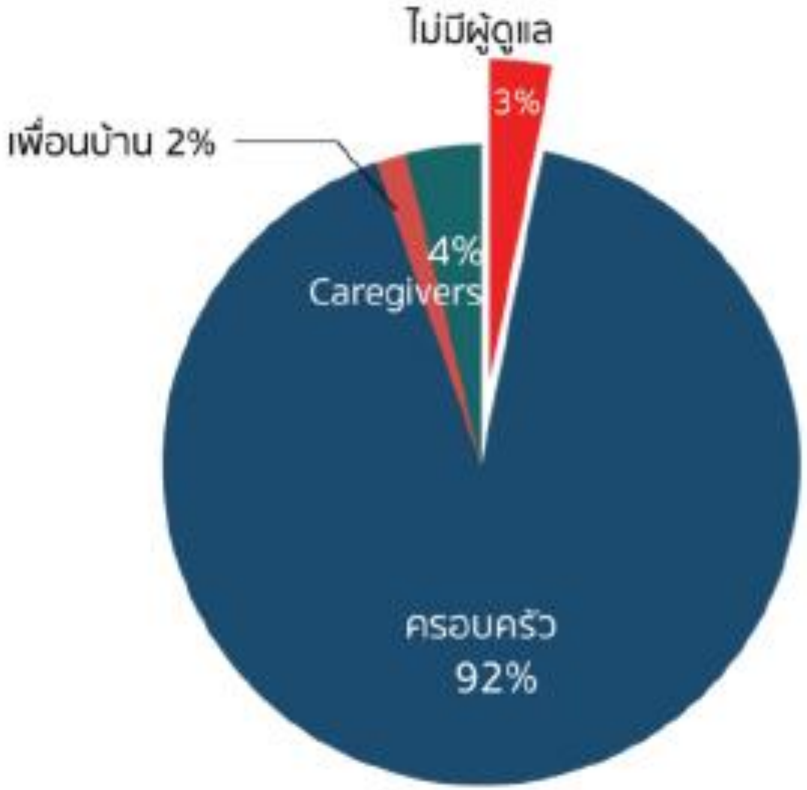
ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 149,958	นอกเขตเทศบาล n = 188,091
สิทธิการรักษา		
กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	117,580 (78.59%)	161,301 (85.82%)
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ	30,768 (20.56%)	25,617 (13.63%)
กองทุนประกันสังคม	1,151 (0.77%)	137 (0.07%)
การเข้าถึงการดูแลระยะยาว	89,924 (60.90%)	154,223 (81.99%)

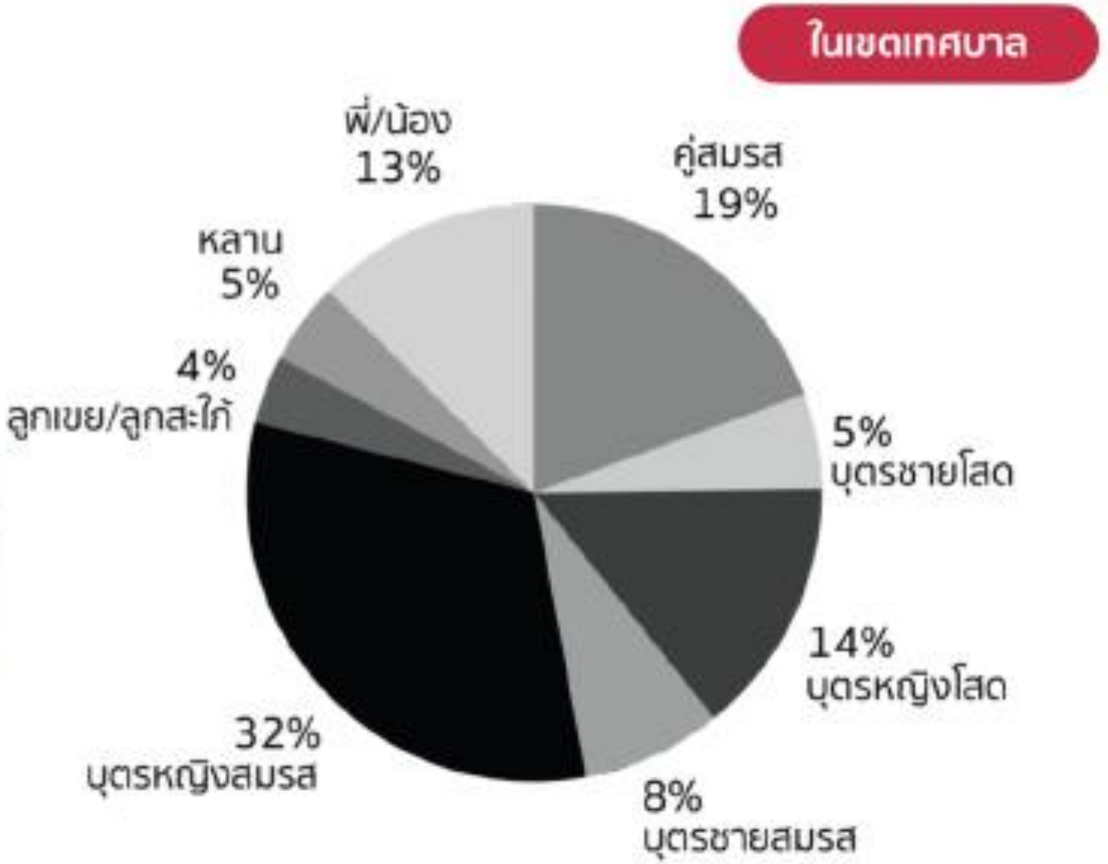
* การได้รับการดูแลระยะยาวหมายถึงการดูแลโดย อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)/ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ/อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อพม.)

ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ

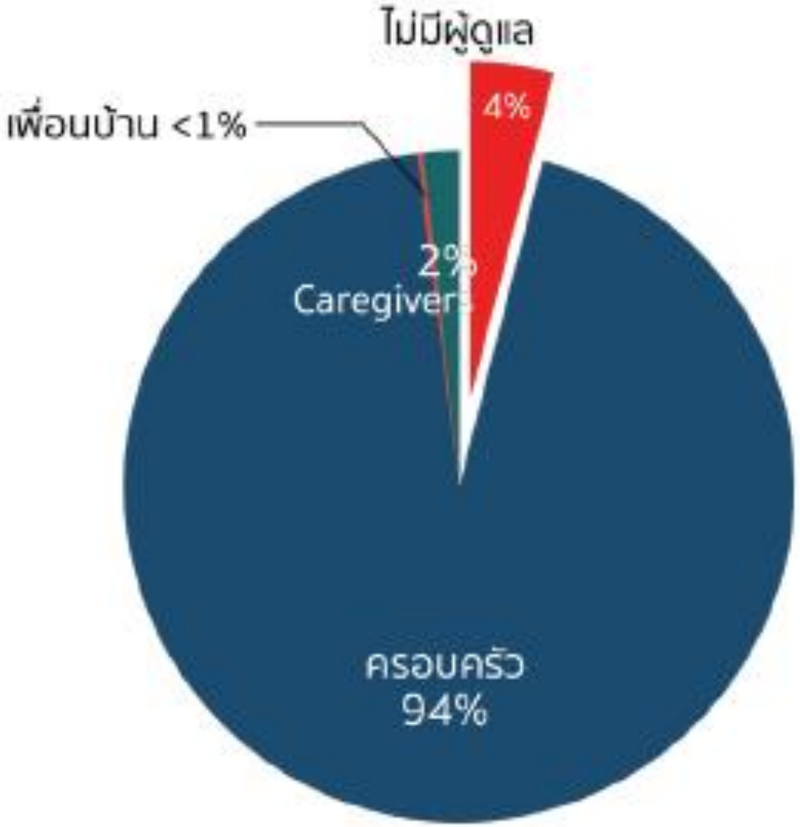


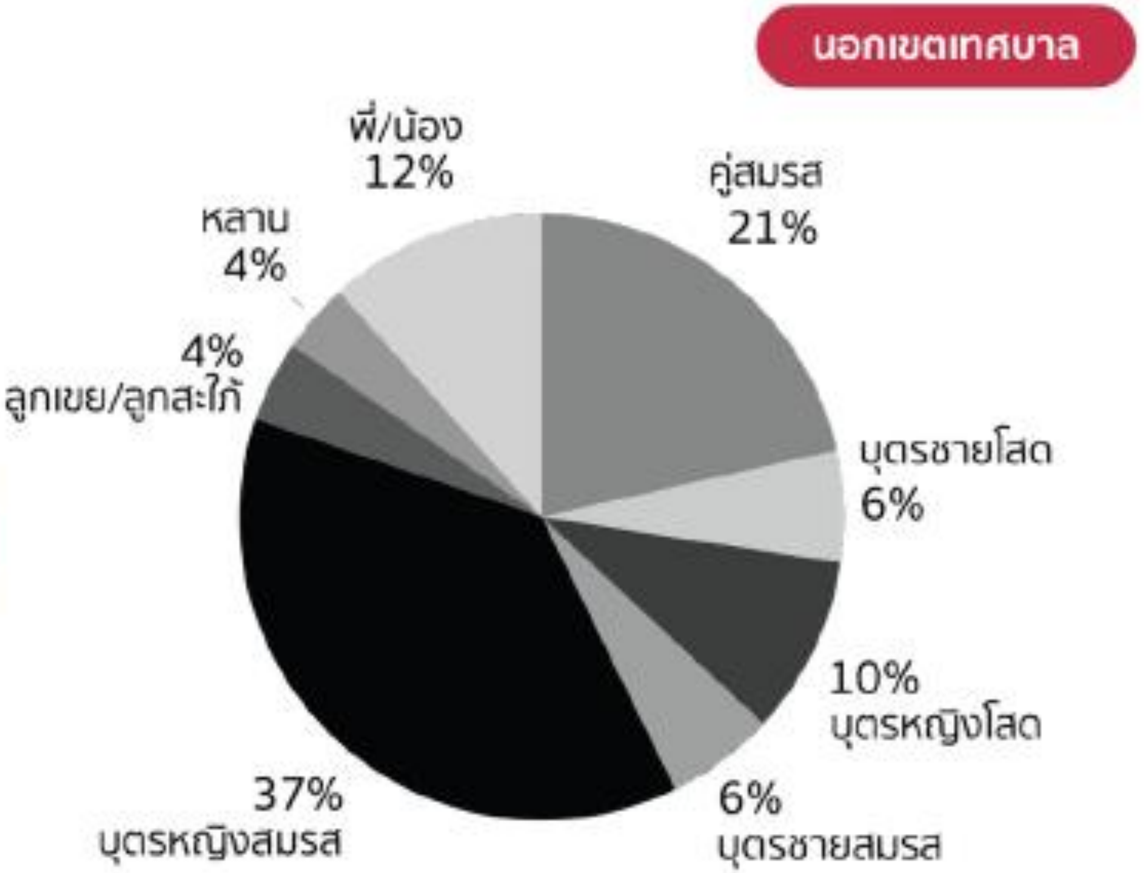


ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ





ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ลักษณะของผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ

ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 126,529	นอกเขตเทศบาล n = 164,801
อายุ	61 (52–69)	58 (49–67)
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	63,909 (50.51%)	99,865 (60.60%)
มัธยมศึกษา	37,431 (29.58%)	46,700 (28.34%)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	25,189 (19.91%)	18,236 (11.07%)

ข้อค้นพบ

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ลักษณะของผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ

ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 126,529	นอกเขตเทศบาล n = 164,801
รายได้ต่อเดือน	10,000 (4,000-30,000)	7,000 (3,000-20,000)
จำนวนผู้ดูแลต้องลาออกมาดูแล	14,062 (9.38%)	20,248 (10.76%)
จำนวนปีที่ลาออกมาดูแล	5 (1-7)	2 (2-5)
ชั่วโมงการดูแลต่อสัปดาห์		
< 1 ชั่วโมง	1,026 (0.81%)	3,220 (1.95%)
1-8 ชั่วโมง	44,625 (35.27%)	79,102 (48.00%)
8-20 ชั่วโมง	32,643 (25.80%)	35,831 (21.74%)
20-40 ชั่วโมง	22,851 (18.06%)	16,688 (10.13%)
> 40 ชั่วโมง	25,384 (20.06%)	29,960 (18.18%)

ข้อค้นพบ

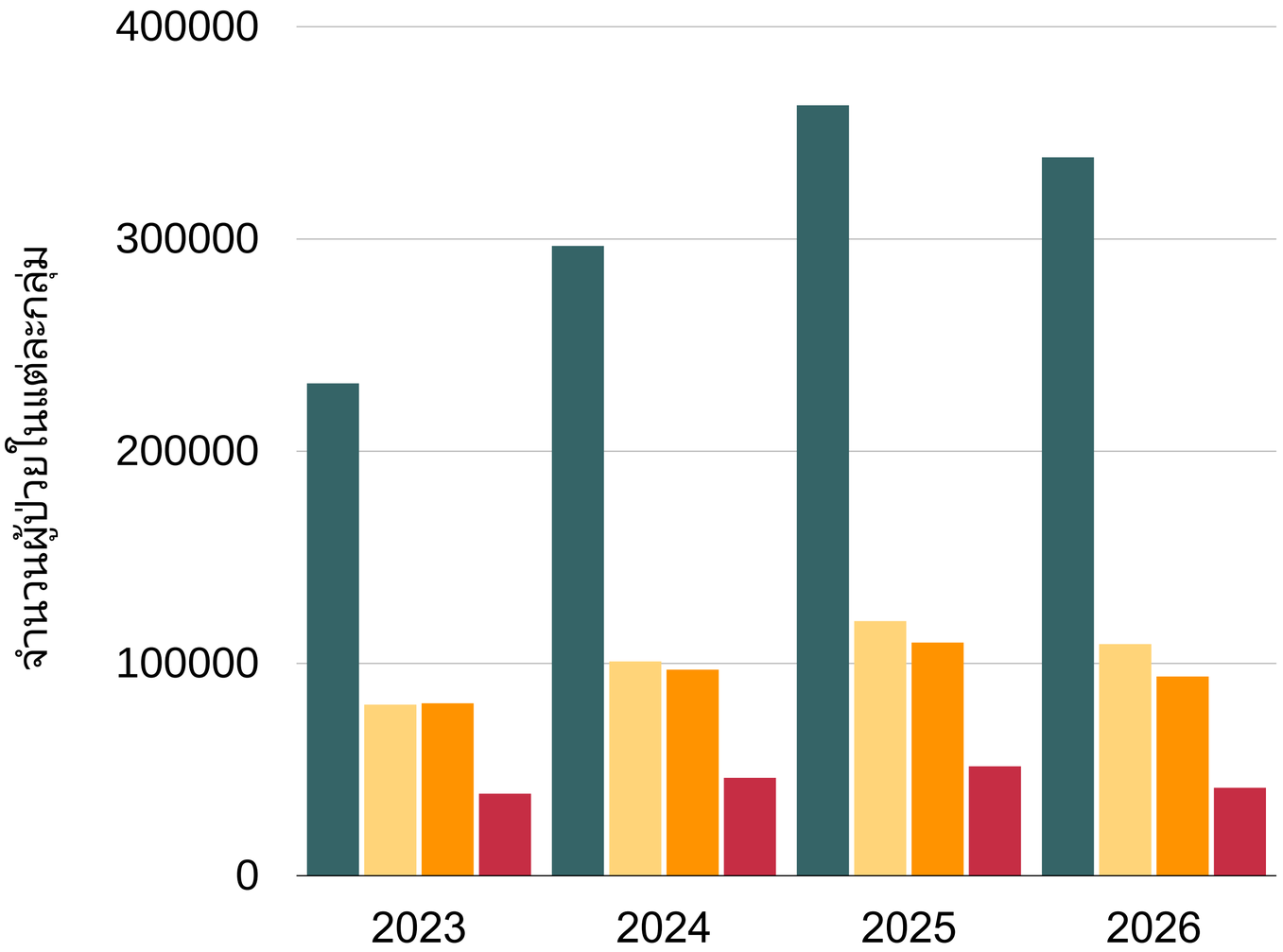
จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2567

ลักษณะของผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุ

ลักษณะประชากร	ในเขตเทศบาล n = 126,529	นอกเขตเทศบาล n = 164,801
การเข้ารับการอบรมการดูแล		
ไม่เคย	106,009 (83.78%)	135,760 (82.38%)
อบรมแบบไม่เป็นทางการ	14,429 (11.40%)	18,861 (11.44%)
หลักสูตร 18 ชั่วโมง	3,507 (2.77%)	7,655 (4.64%)
หลักสูตร 70 ชั่วโมง	1,832 (1.45%)	1,396 (0.85%)
หลักสูตร 420 ชั่วโมง	751 (0.59%)	1,130 (0.69%)

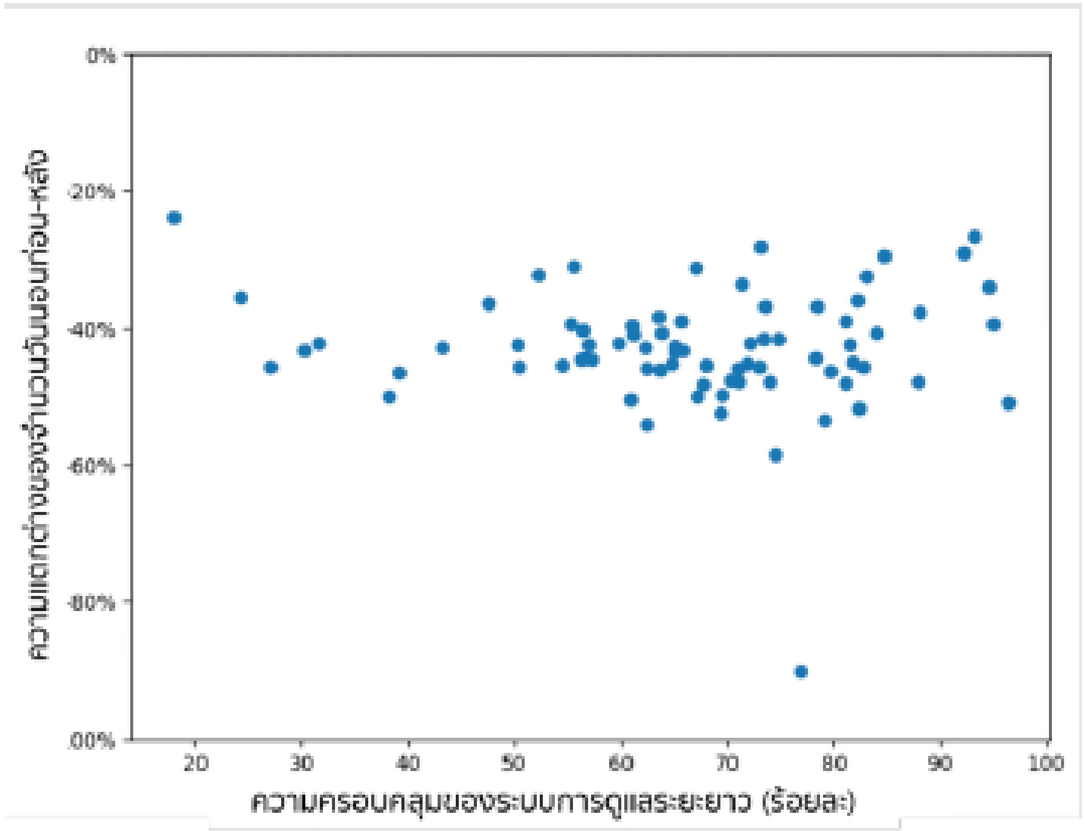
ข้อค้นพบ

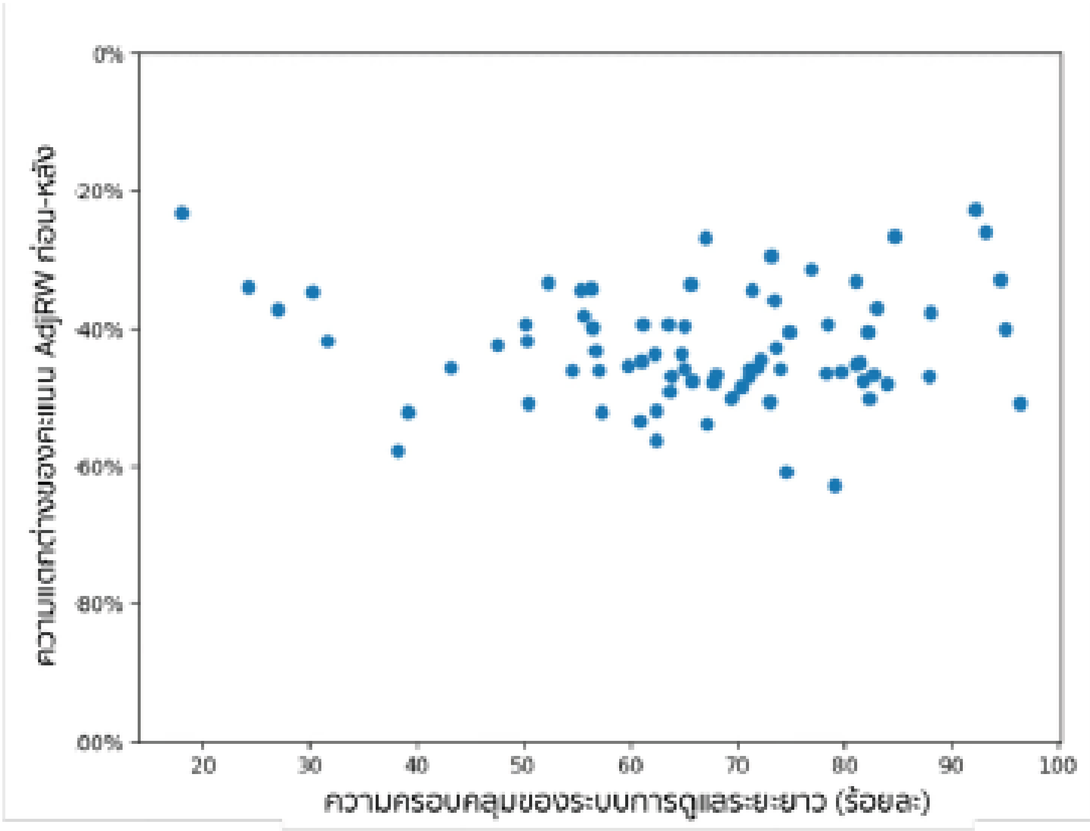
จากฐานข้อมูลบริการการดูแลระยะยาวของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



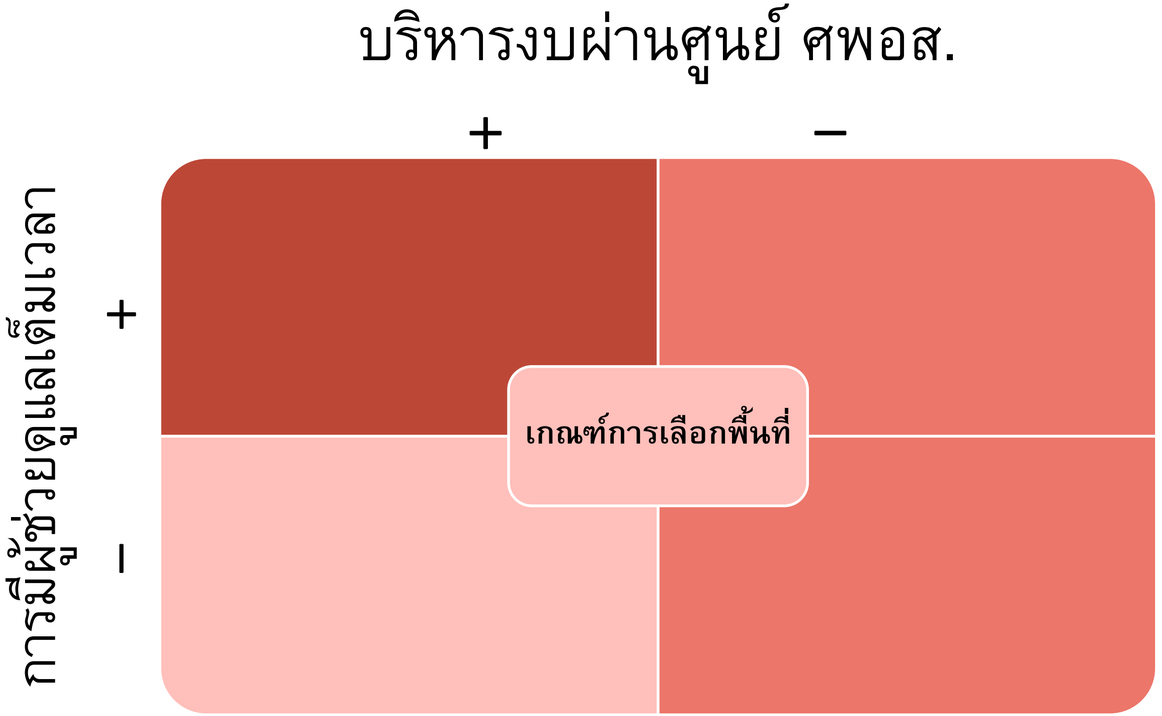
กลุ่มผู้ป่วย	ระยะเวลาที่อยู่ในระบบ (เดือน)
กลุ่มที่ 1	19 (8-38)
กลุ่มที่ 2	18 (7-36)
กลุ่มที่ 3	16 (5-32)
กลุ่มที่ 4	13 (4-28)

ความสัมพันธ์ของความครอบคลุมและการเปลี่ยนแปลงของจำนวนวันนอนและ AdjRW





หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนวันนอนเฉลี่ยและค่า AdjRW มาจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในของ สปสช.



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ลพบุรี สตูล

สัญญาณเตือนเชิงปริมาณ: ภาระหนักที่ตกอยู่กับ "ครอบครัวเปราะบาง"

51%

ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี พึ่งพารายได้จากครอบครัวเป็นหลัก (ขาดความมั่นคงจากกลไกสถาบัน)

91-94%

ผู้ดูแลหลักคือ "คนในครอบครัว" (ส่วนใหญ่เป็นบุตรหญิงและคู่สมรสวัย 56-58 ปี สะท้อนภาวะ Aging Caregivers)

10%

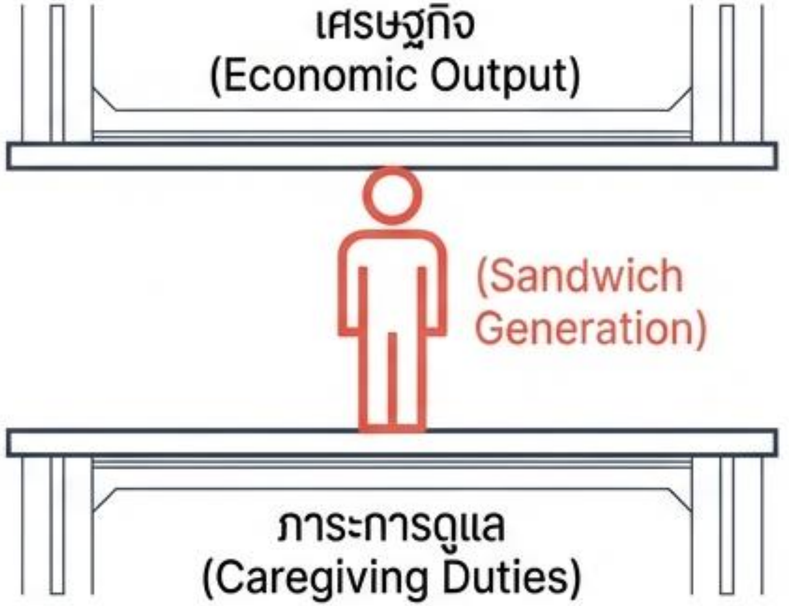
ประชากรวัยแรงงานต้องลาออกจากงานมาดูแลเฉลี่ยนาน 3-4 ปี (Opportunity Cost ต่อระบบเศรษฐกิจ)

84%

ผู้ดูแลหลักไม่เคยผ่านการอบรมทักษะ เกิดความเสี่ยงแฝงทางคลินิก (Clinical Risks)

เป้าหมายสูงสุด: คุ้มครองวัยแรงงานและรักษาระบบนิเวศเศรษฐกิจ



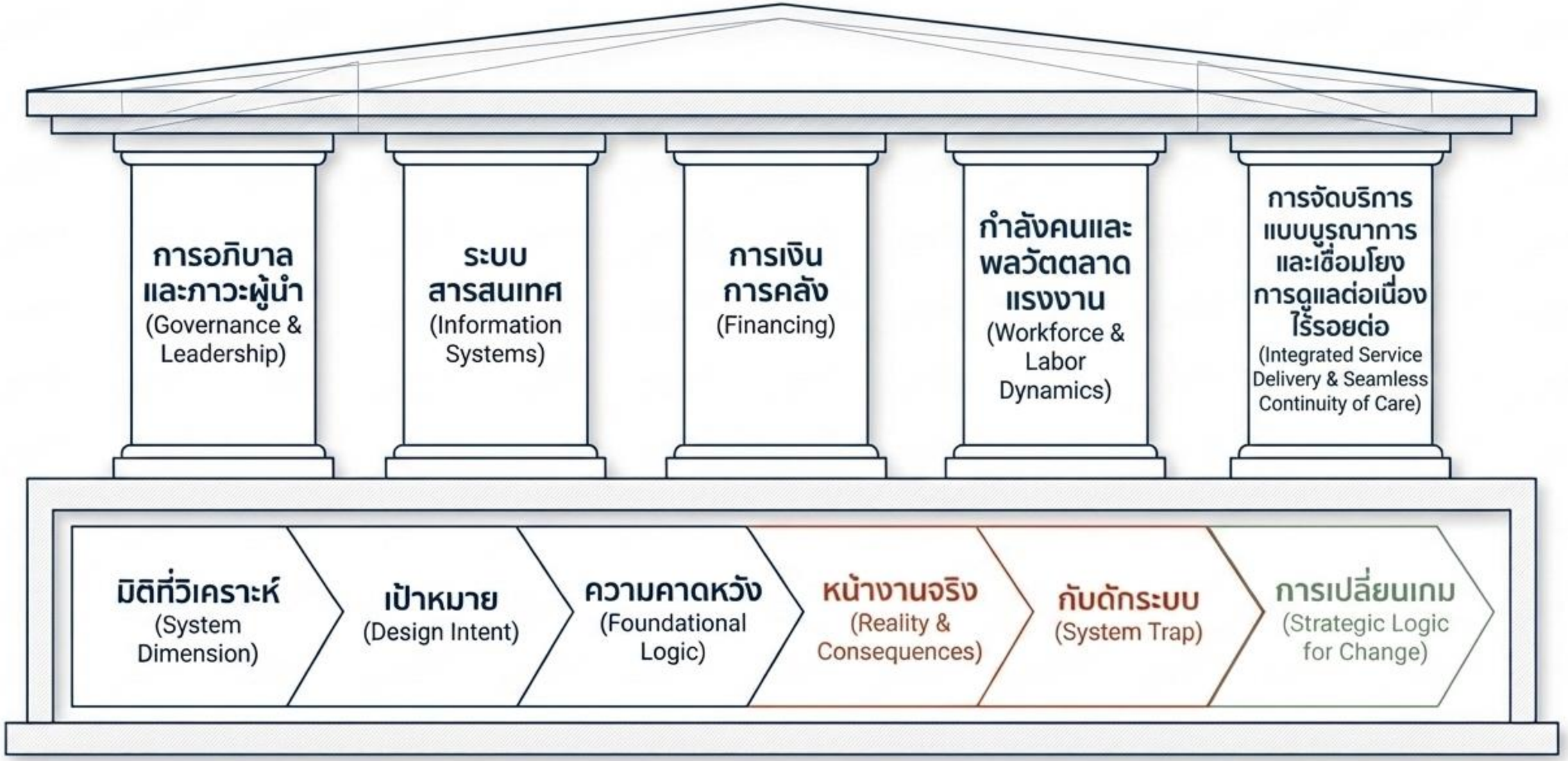


บริบท: ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2574

ความเสี่ยงมหภาค: ประชากรวัยแรงงาน (Sandwich Generation) เสี่ยงหลุดออกจากระบบเศรษฐกิจเพื่อเป็นผู้ดูแลเต็มเวลา กระทบฐานภาษีและความมั่นคงของประเทศ

เป้าหมายระบบ: บูรณาการการรักษาพยาบาล (Medical care) และสวัสดิการสังคม (Social welfare) อย่างไร้รอยต่อ เพื่อสร้างเศรษฐกิจการดูแล (Care Economy)

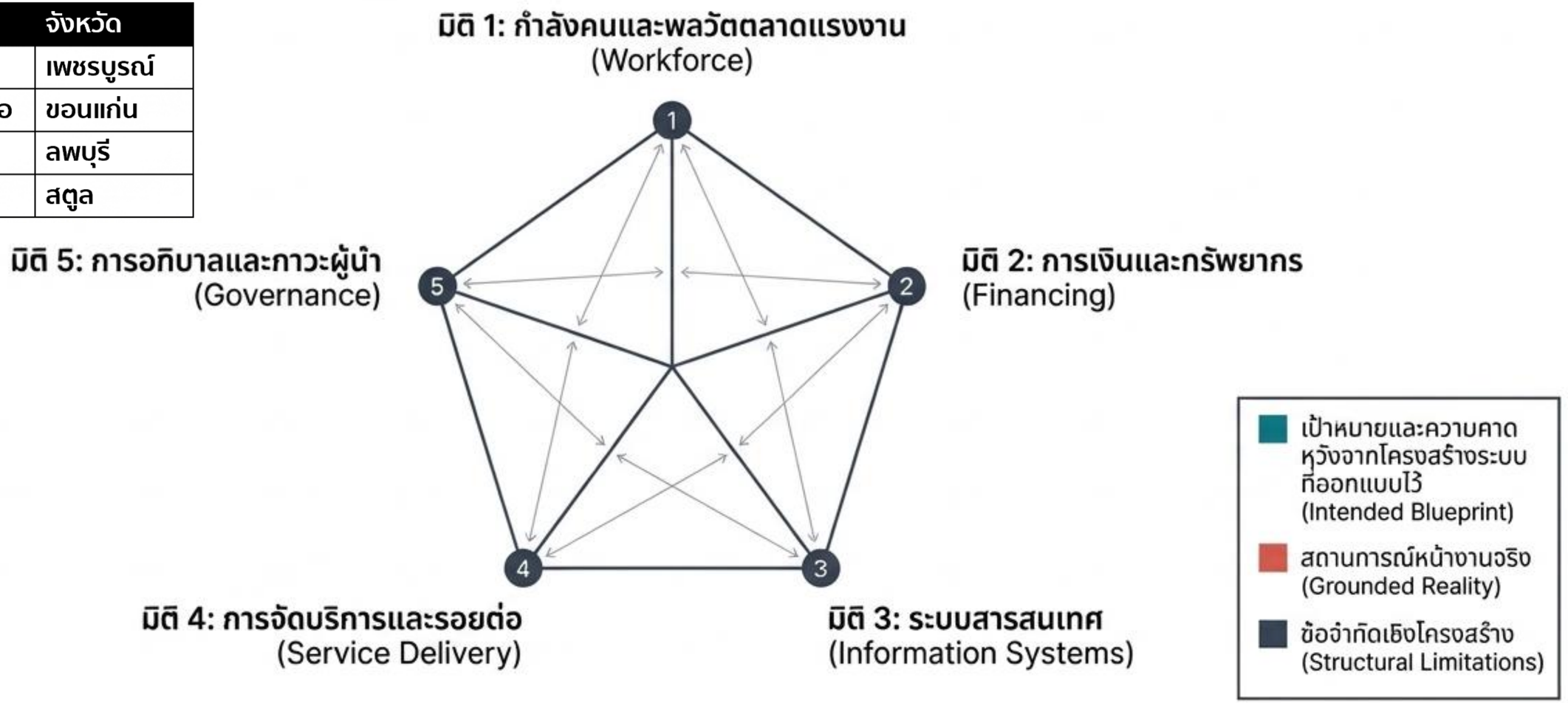
โครงสร้างการวิเคราะห์พลวัตเชิงระบบ (Systemic Framework)



รหัสข้อจำกัด 5 มิติ: ช่องว่างระหว่างการออกแบบและการปฏิบัติจริง (The Design-Implementation Gap)

แม้โครงสร้างนโยบายชัดเจน แต่ระบบยังเผชิญช่องว่างเชิงประจักษ์ การถอดรหัสเสียงสะท้อนจากพื้นที่ 4 กูมิภาค นำไปสู่การวิเคราะห์ 5 มิติหลัก:

ภาค	จังหวัด
เหนือ	เพชรบูรณ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น
กลาง	ลพบุรี
ใต้	สตูล

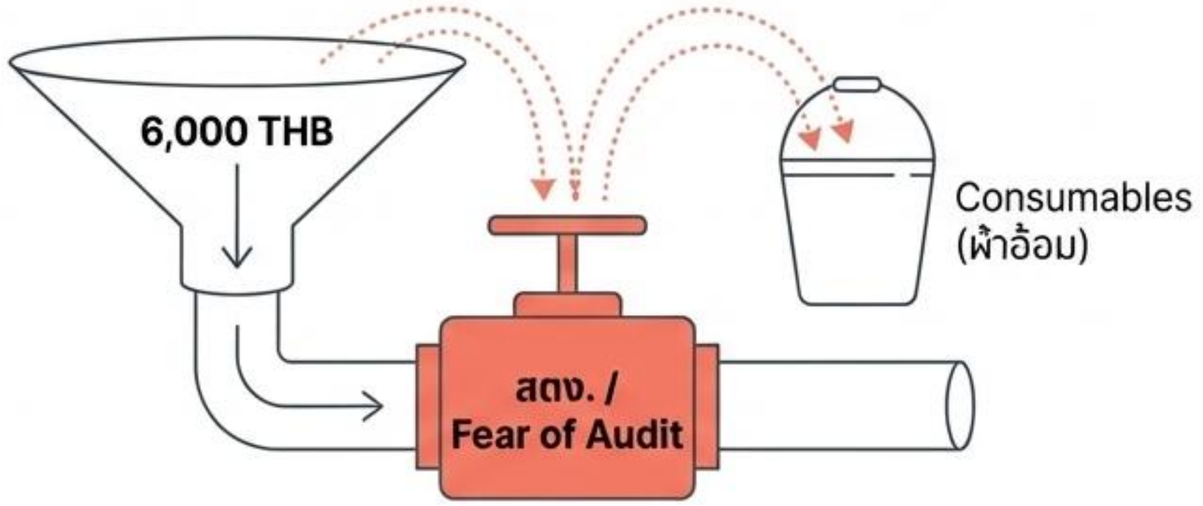


มิติที่ 1: ขีดจำกัดของกำลังคนและ "สภาวะสมองไหล" (Workforce & Labor Dynamics)



เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended System Design & Expectations)	สถานการณ์หน้างานจริง (On-the-Ground Reality)	ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง (Structural Limitations)
คาดหวังการ**ใช้กำลังคนในชุมชน (CG)** ที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ให้บริการที่บ้าน บริหารจัดการโดยพยาบาลผู้จัดการการดูแล (CM)	ระบบถูกพยุงด้วย **"ทุนทางสังคมเชิงเสียสละ"** (Sacrificial Social Capital) ทำงานด้วย "ใจรัก" ค่าตอบแทน 5,000-6,000 บาท/เดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ CM แบกรับงานคลินิกซ้อนทับงานเอกสาร เสี่ยงต่อภาวะ**หมดไฟ** (Burnout)	**The Limits of Volunteerism:** การพึ่งพาใจรักไม่ใช่ความยั่งยืนเชิงระบบ **The Wage Gap:** ค่าตอบแทนที่แท้จริงเพื่อเป็นอาชีพ (Living Wage) ควรอยู่ที่ 10,000-15,000 บาท เกิด **"สภาวะสมองไหล"** (Brain Drain) บุคลากรย้ายไปภาคเอกชนที่ให้ค่าตอบแทน 20,000-25,000 บาท

มิติที่ 2: กับดักงบประมาณและความกลัวการตรวจสอบ (Financing & Resource Procurement)



เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended System Design & Expectations)

- งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) 6,000 บาท/คน/ปี เข้ากองทุนท้องถิ่น (กปท.)
- กระจายอำนาจให้พื้นที่จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ได้ตามความเหมาะสม

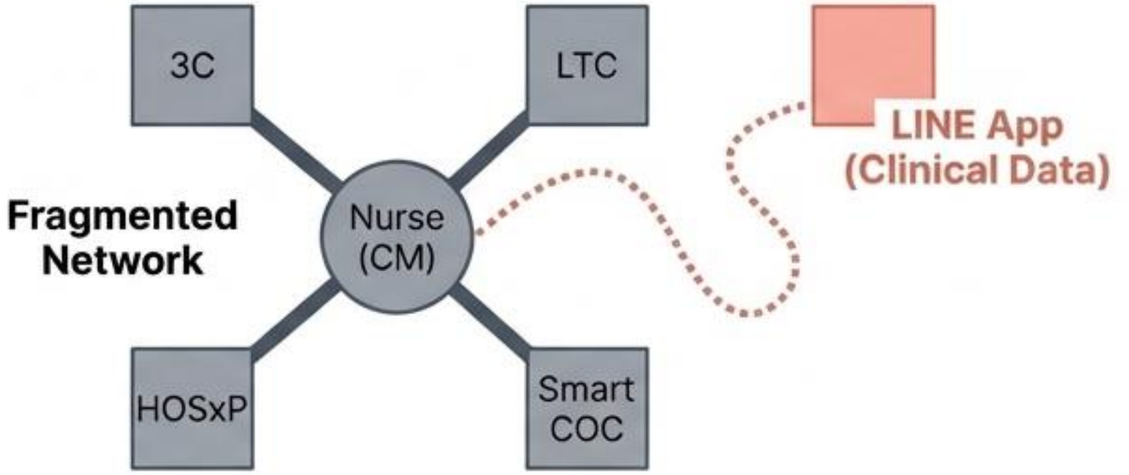
สถานการณ์หน้างานจริง (On-the-Ground Reality)

- งบ 70-80% ถูกใช้ไปกับวัสดุสิ้นเปลือง (ผ้าอ้อม) และค่าตอบแทน CG (50 บาท/ชม.)
- ชุมชนต้องพึ่งพา "การระดมทุนภาคประชาชน" (เช่น ทำผ้าป่า) เพื่อซื้อครุภัณฑ์ราคาสูง (เตียง, เครื่องผลิตออกซิเจน)

ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง (Structural Limitations)

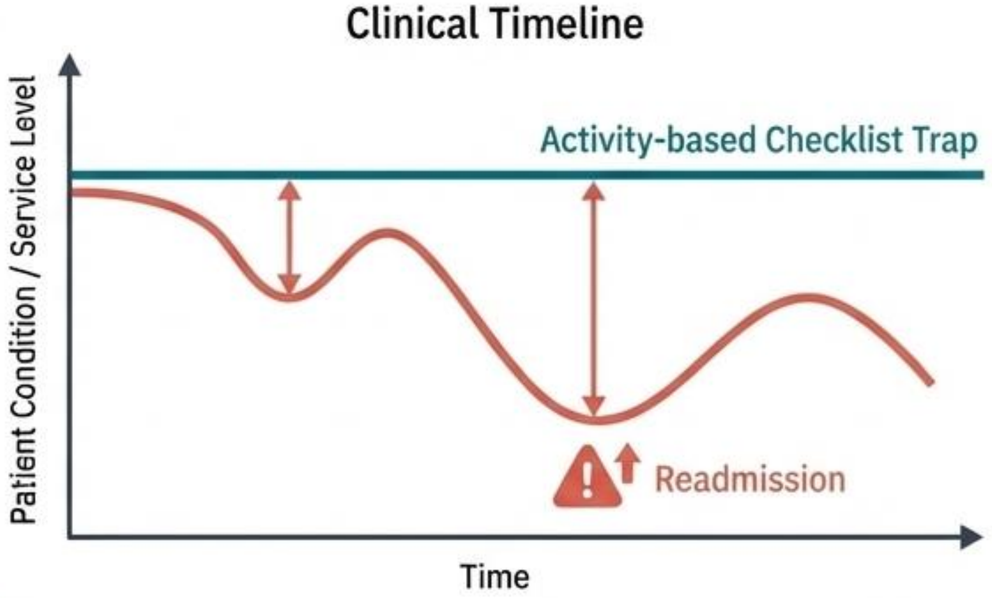
- Rigid Capitation: งบรายหัวเท่ากันหมด ไม่สะท้อนความซับซ้อนของภาวะพึ่งพิงแต่ละราย
- Fear of Audit: ท้องถิ่นกังวลการตรวจสอบจาก สตง. ทำให้ยึดติดระเบียบพัสดุอย่างรัดกุม
- ผลลัพธ์คืองบประมาณไม่ถูกใช้เพื่อการลงทุนในอุปกรณ์ที่ช่วยเปลี่ยนผลลัพธ์ทางคลินิก

มิติที่ 3: ภาระข้อมูลซ้ำซ้อนและการสูญหายของข้อมูลวิกฤต (Information Systems)

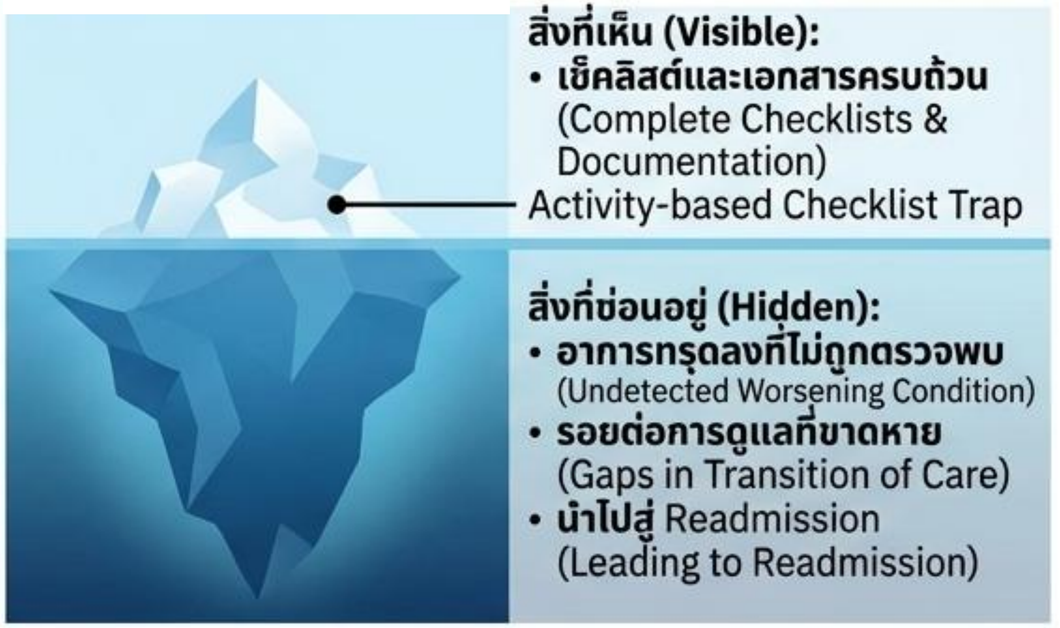


เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended System Design & Expectations)	สถานการณ์หน้างานจริง (On-the-Ground Reality)	ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง (Structural Limitations)
• ใช้ระบบสารสนเทศส่วนกลางบูรณาการข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ • ติดตามคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ	• Fragmented Systems: ภาระบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายแพลตฟอร์ม (3C, ระบบ LTC, HOSxP, สอน.บัดดี้) • ข้อมูลสำคัญทางคลินิก (เช่น ภาพแผลกดทับ) ถูกส่งผ่านช่องทางส่วนตัว (LINE) ไม่ถูกจัดเก็บในระเบียนสุขภาพแห่งชาติ (HIS)	• Process-oriented Indicators: ระบบมุ่งประเมินเชิงกระบวนการ (จำนวนครั้งที่เยี่ยม, เอกสารครบถ้วน) เพื่อการเบิกจ่าย • ขาดตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางคลินิก (Clinical Outcomes) ที่ได้พอจะประเมิน ‘ความเร็วของการเสื่อมถอย’ ของผู้ป่วย

มิติที่ 4: กับดักเช็คลิสต์และรอยต่อการดูแลที่ขาดหาย (Service Delivery & Transition of Care)



เปรียบเทียบ (Comparison)



เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended System Design & Expectations)	สถานการณ์หน้างานจริง (On-the-Ground Reality)	ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง (Structural Limitations)
• ส่งมอบบริการต่อเนื่องไร้รอยต่อ (Seamless Care) ตั้งแต่ระยะฟื้นฟู (IMC) -> ระยะยาว (LTC) -> ระยะท้าย (Palliative)	• ตกอยู่ใน "กับดักการจัดบริการเชิงกิจกรรมที่แข็งตัว" (Activity-based Checklist Trap) • บริการตายตัวตามรอบงบประมาณ เมื่อผู้ป่วยทรุดลงเฉียบพลัน ระบบปรับตัวไม่ทัน สัญญาณเตือนถูกมองข้าม จบลงที่การกลับเข้าโรงพยาบาลซ้ำ (Readmission)	• Linear Design: ผูกการเบิกจ่ายกับปริมาณกิจกรรม ไม่ใช่ผลลัพธ์ • Rigid Budget Cycles: การอนุมัติงบ Care Plan เป็นรายไตรมาส/รายปี ไม่สอดคล้องกับพลวัตของโรค • ขาด "ผู้จัดการระบบ" ระดับอำเภอ และขาดศูนย์ดูแลชั่วคราว (Respite care)

มิติที่ 5: ภาวะพึ่งพาตัวบุคคลและช่องว่างทางคลินิก (Governance & Leadership)



เป้าหมายและความคาดหวังจากโครงสร้างระบบที่ออกแบบไว้ (Intended System Design & Expectations)

กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นเจ้าภาพหลักในการอภิบาลระบบสุขภาพระดับพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ

สถานการณ์หน้างานจริง (On-the-Ground Reality)

Individual Leadership Dependency: ความสำเร็จขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำท้องถิ่นเป็นรายบุคคล หากขาดการสนับสนุน ระบบจะชะงักงัน

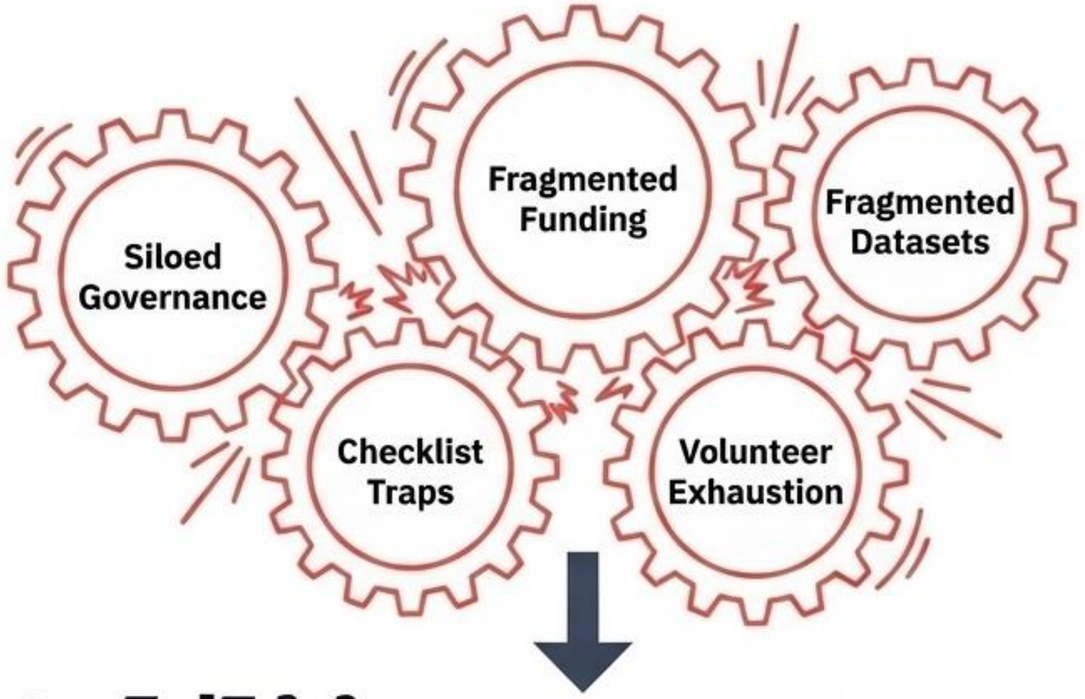
อปท. หลายแห่งรับมือได้เพียงงานธุรการ ขาดศักยภาพรับมือผู้ป่วยซับซ้อน (Non-health background)

ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง (Structural Limitations)

คณะกรรมการระดับชาติทำงานแยกส่วน ขาดการบูรณาการ

Clinical Governance Gap: หลังถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. เกิดรอยต่อในการทำงานร่วมกับ รพ.แม่ข่าย (CUP) ฐานข้อมูลถูกตัดขาด ขัดขวางการทำงานของทีมสหวิชาชีพ

บทสรุปการวิเคราะห์: เมื่อข้อจำกัดเชิงโครงสร้างทวีคูณ (The Systemic Gridlock)



ระบบปัจจุบันไม่ได้ล้มเหลวจากการขาดความตั้งใจ แต่ชะงักงันเพราะ "กลไกที่ขัดแย้งกันเอง"

- การเงินที่แข็งตัว (มิติ 2) + ข้อมูลที่เน้นกระบวนการ (มิติ 3) บังคับให้เกิดกับดักเช็คลิสต์ (มิติ 4)

- การพึ่งพาทุนทางสังคมเชิงเสียสละ (มิติ 1) ภายใต้ท้องถิ่นที่พึ่งพาตัวบุคคล (มิติ 5) ทำให้ไม่สามารถขยายผลสู่ความยั่งยืนได้

- Result: ระบบมุ่งเน้นความถูกต้องของงานเอกสารมากกว่าผลลัพธ์ทางคลินิก นำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล

ข้อเสนอที่ 1: ยกระดับสู่ "ธรรมาภิบาลเชิงสถาบัน" และฐานข้อมูลอัจฉริยะ

เปลี่ยนผ่านจากระบบที่พึ่งพา "ตัวบุคคล" สู่ Institutional Governance



Process-Oriented



Clinical & Social Outcomes

1. Integrated Care Plan:
ใช้แผนการดูแลแบบบูรณาการเป็น **"จุดคานงัด"** (Leverage Point) ให้ผู้จัดการระบบทำงานได้ไร้รอยต่อ

2. Data as an Intelligence Tool:
ยกระดับระบบข้อมูลจากการงานเอกสาร สู่**มาตรฐานประเมินผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านคลินิกและด้านสังคม (เช่น มาตรฐาน interRAI)**

3. From Process to Outcomes:
เลิกวัดปริมาณกิจกรรม หันมาวัด **"ความมั่นคงทางสรีรวิทยา"** (Physiological Stability) และป้องกันอันตรายที่หลีกเลี่ยงได้ (Zero Preventable Harm) เพื่อให้ส่วนกลางจัดสรรทรัพยากรตามความเป็นจริงได้อย่างอัตโนมัติ

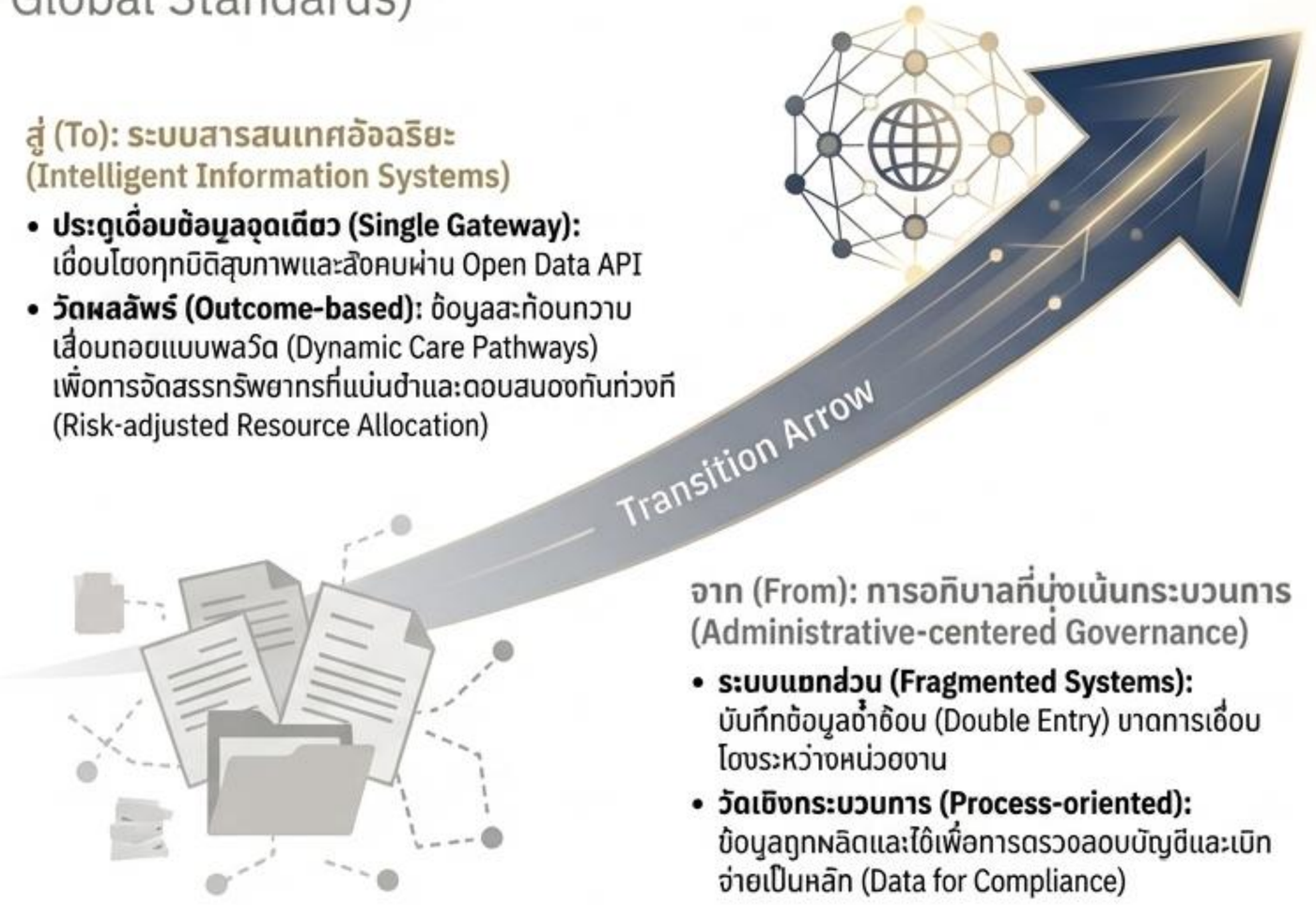
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านระบบข้อมูล LTC: จากภาระงานเอกสารสู่ปัญญาเชิงบริบาลมาตรฐานสากล

(Elevating LTC Information Systems to Global Standards)



โอกาสทองของประเทศไทย (Strategic Window of Opportunity)

- การปฏิรูประบบสารสนเทศและการวัดผลการดูแลระยะยาว (LTC) สู่มาตรฐาน interRAI คือยุทธศาสตร์สำคัญในขณะที่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD
- การใช้เครื่องมือประเมินที่เป็นภาษากลางระดับสากลจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเดิม ทำให้ไทยสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Benchmarking) และยกระดับระบบความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ให้ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานโลก



สู่ (To): ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ (Intelligent Information Systems)

- **ประตูเชื่อมข้อมูลจุดเดียว (Single Gateway):** เชื่อมโยงทุกมิติสุขภาพและสังคมผ่าน Open Data API
- **วัดผลลัพธ์ (Outcome-based):** ข้อมูลสะท้อนความเสื่อมถอยแบบพลวัต (Dynamic Care Pathways) เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่แม่นยำและตอบสนองทันท่วงที (Risk-adjusted Resource Allocation)

จาก (From): การอภิบาลที่มุ่งเน้นกระบวนการ (Administrative-centered Governance)

- **ระบบแยกส่วน (Fragmented Systems):** บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน (Double Entry) ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
- **วัดเชิงกระบวนการ (Process-oriented):** ข้อมูลถูกผลิตและใช้เพื่อการตรวจสอบบัญชีและเบิกจ่ายเป็นหลัก (Data for Compliance)

แผนภูมิวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านตัวชี้วัด LTC สู่มาตรฐานสากล

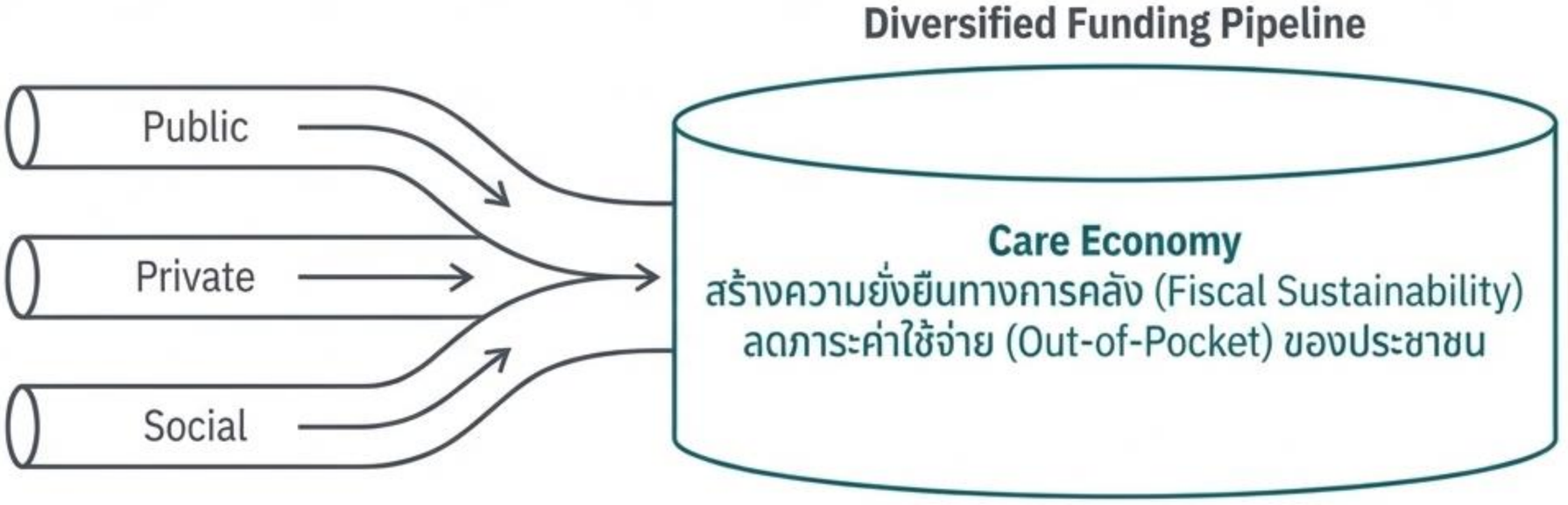
(Indicator Redesign Matrix: Transitioning to interRAI Quality Indicators)

มิติการประเมิน (Domain)	ข้อมูลและตัวชี้วัดระบบเดิมในปัจจุบัน (Current System & QIs)	ข้อจำกัดของระบบเดิม (System Limitations)	ประเด็นการวัดด้วยมาตรฐาน interRAI (interRAI Measurement Focus)	เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Change Idea)
1. สมรรถภาพทางกาย (Physical Function & ADLs)	วัดความครอบคลุมของการทำแผนการดูแล (Care Plan) และบันทึกปริมาณกิจกรรมตามตาราง	**มุ่งเน้นเชิงกระบวนการ (Process-oriented):** สนใจความครบถ้วนทางเอกสาร ขาดเครื่องมือวัดความเร็วของการเสื่อมถอยอย่างเป็นพลวัต (Static Snapshot)	**วัดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Incidence QIs):** ประเมินทิศทางการถดถอย หรือการรักษาสภาพสมรรถนะการทำกิจวัตร (Late/Mid-loss ADLs)	**เฝ้าระวังเพื่อชะลอความเสื่อมถอย:** ใช้ข้อมูลหา 'ช่วงเวลาทอง' (Golden Period) ในการฟื้นฟู และให้รางวัลเมื่อสามารถรักษาสภาพผู้ป่วยได้ (Stability Pay)
2. ความปลอดภัยทางคลินิก (Safety & Clinical Risk)	ตรวจสอบการมีอยู่ของทีมเยี่ยมบ้าน และสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์การแพทย์	**ติดข้อจำกัดด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Trap):** ไม่เชื่อมโยงทรัพยากรที่ใช้กับอุบัติการณ์ทางสุขภาพ ทำให้ความเสี่ยงถูกรายงานล่าช้า	**วัดผลลัพธ์ทางคลินิก (Clinical Outcomes):** อุบัติการณ์เกิดแผลกดทับรายใหม่ (New Pressure Ulcers), การหกล้ม (Falls) ภายใน 30-90 วัน	**ระบบประกันความปลอดภัยร่วมกัน:** บูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันอันตรายที่หลีกเลี่ยงได้ (Zero Preventable Harm) ขับเคลื่อนท้องถิ่นปรับสภาพบ้านดรงจุด
3. ผู้ดูแลและสังคม (Social & Caregiver Support)	วัดจำนวนชมรมผู้สูงอายุ, สัดส่วนผู้ดูแล (CG) เทียบกับจำนวนผู้ป่วย	**วัดเชิงปริมาณ (Quantity Trap):** ขาดเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินระดับความเปราะบางและสภาวะหมดไฟของผู้ดูแลอย่างเป็นระบบ	**วัดผลกระทบทางจิตสังคม (Psychosocial QIs):** ระดับความเครียดหรือความทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องของผู้ดูแล (Caregiver Distress), ภาวะโดดเดี่ยว	**รักษาระบบนิเวศการดูแล (Care Ecology):** ใช้ข้อมูลความเครียดเป็น 'ดัชนีเตือนภัย' เพื่อกระตุ้นระบบสนับสนุนสังคม (Respite Care) ก่อนครอบครัวพังทลาย
4. ความสมบูรณ์ทางสรีรวิทยา (Clinical Integrity)	ร้อยละของการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการลงบันทึก Checklist กิจกรรมพยาบาล	**ขาดความไวในการเฝ้าระวัง (Sensitivity Gap):** มองข้ามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างปีนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ไม่ได้คาดคิด	**วัดความมั่นคงทางสรีรวิทยา (Physiological Stability):** น้ำหนักตัวที่ลดลงผิดปกติ, ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium), การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTI)	**จัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ:** เปลี่ยนจากทำตามตาราง สู่การติดตามสัญญาณชีพเพื่อเข้าแทรกแซงทันท่วงที ลดอัตราการกลับเข้าโรงพยาบาลซ้ำ (Readmission)

บทสรุป (Key Takeaway): การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือการทลายกับดักข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ยกระดับจากการอภิบาลตาม 'ระเบียบธุรการ' สู่การจัดซื้อบริการเชิงยุทธศาสตร์ที่อิง 'ผลสัมฤทธิ์และคุณค่า' (Value-based Purchasing) เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบในระยะยาวและการเชื่อมต่อระดับโลก

ข้อเสนอที่ 2: นวัตกรรมพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Building Partnerships)

แก้ปัญหาวิกฤตล้มละลายของครัวเรือนเปราะบาง ด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์



1. Social Impact Bonds (SIB):
สร้างแหล่งรายได้ใหม่ผ่านพันธบัตรร่วมทุนทางสังคม

2. Public-Private Partnership (PPP):
กระตุ้นกลไกความร่วมมือรัฐและเอกชนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแล

3. Social Innovation Sandbox:
จัดตั้งพื้นที่ทดลองนวัตกรรม สนับสนุน "วิสาหกิจเพื่อสังคม" (Social Enterprise) ให้ร่วมจัดบริการ "การดูแลชั่วคราว" (Respite Care)

ข้อเสนอที่ 3: ทลายกับดักระบบอาสาสมัคร สู่ "ความเป็นมืออาชีพ" (Break the Volunteerism Trap)

เปลี่ยน "ทุนทางสังคมเชิงเสียสละ" ให้เป็นกำลังแรงงานมืออาชีพในเศรษฐกิจการดูแล



1. Dedicated Focus Role:
กำหนดตำแหน่งผู้ดูแลแบบเต็มเวลา (Full-time CG) และผู้จัดการการดูแล (CM) ให้เป็นวิชาชีพเฉพาะทาง

2. Living Wage & Incentives:
รับรองค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อค่าครองชีพจริง และมีเงินรางวัลจูงใจตามผลงาน (Performance-based Incentive) เพื่อหยุดยั้งสภาวะสมองไหล

3. Empowering System Managers:
ยกระดับทักษะ "ผู้จัดการระบบระดับอำเภอ/จังหวัด" ด้าน Data Analytics เพื่อออกแบบชุดบริการที่ตอบสนองคนในพื้นที่ (Locally Responsive Needs)